جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شريفه عبدالله عويس حسنين
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** الصف **العنوان :** قريه الصف
رقم البطاقة : 28402162100722 **رقم التليفون :** 01124324795 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 16-02-1984 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي Anthracyclines base [14151] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شريفه عبدالله عويس حسنين
National ID: 28402162100722

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Anthracycline-based chemotherapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
شريفه
عبدالله عويس حسنين
قرية الصف
مركز الصف - الجيزه
٢٨٤ ٠٢١٦ ٢١ ٠٠٧٢٢
١٩٨٤/٠
I08907268

٠١١٢٤٣٠٢٤٧٩٥

٠١١٠٢٩٨٢٥٠٤٨

غـــــــ

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لـدعـم صحة المرأة المصرية

08/18/2026

MDT FORM

Name:	شريفه عبدالله عويس حسنين	**MRN:**	12970
Age:	43 Y	**ID:**	28402162100722
Menopausal Status:	PRE	**Phone:***	01124324795
NRS SCORE:	PS 0	**Marital Status:**	MARRIED
BMI:	25	**Family History:**	+VE
Gender			
CO Morbidity:	HTN	**Reason Of MDT:** *	NEW CASE
Surgical History: *	CS	**ECOG Performance Status**	◉ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: LT IDC G III

ER: 8/8 **PR:** 5/8 **HER2** +1 LO\ **KI67** 70 %

History:

INITIAL PHOTO ATTACHED

Sonomammography:

1 o'clock irregular heterogeneous hypoechoic mass lesion, measuring
4.32 x 2.79 cm, with anterior extension measuring about 2.44 cm
located about 4 cm from nipple, 0.64 cm from overlying skin, showing
internal vascularity on color Doppler study. ACR-C
Retroareolar prominent hyperechoic ducts.
• Normal nipple/areolar complex.

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

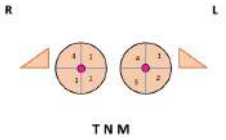
enhancing neoplastic mass lesion in the left breast. The overlying skin is
thickened, more in the peri-areolar region with left axillary metastatic lymph
nodes.
• Hyperinflated both lungs with bilateral increased broncho-

Recommendations:

FOR NACT THEN LT BAT-WING WLE +LN ACCORDINGLY
CESM REQUESTED (DR NBRAWAY)

MDT Outcome & Plan

CESM
for clip insertion afer CESM
neoadj AC * 4 cycles then taxotere *4
THEN LT BAT-WING WLE +LN ACCORDINGLY



TNM

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

T2 N0 M0
SLIGHT PERIAREOLAR EDEMA AND THICKNESS AROUND

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د حنان عزت	د محمد نبراوي		

Patient's Name: **Sharifah Abdallah Ewais Hasanen**
Date: **2026-08-09**
Referred by: Prof.Dr. **no doctor**
Hospital: **Goustave Roussey International Egypt**



MULTISLICE CT EXAMINATIUON OF THE CHEST ,ABDOMEN AND PELVIS WITH CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-

- An enhancing neoplastic mass lesion is seen in the upper outer,peri-areolar region of the left breastwith irregular outlines and measures about 42x39 mm in dimensions. The overlying skin is thickened,more in the peri-areolar region and measures about 12 mm in the peri-areolar region.
- Pathologically-enlarged left axillary lymph nodes are seen with loss of their hilar fat contents and the largest one measures about 30x27mm in dimensions.
- **Normal right breast.**
- **Benign-looking right axillary lymph nodes are seen with preserved their hilar fat contents and the largest one measures about 21 mm.**
- Hyperinflated both lungs.
- Bilateral increased broncho-vascular markings are seen.
- No sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules ,patchy areas of consolidations or calcifications noted.
- No sizable abnormally-enhancing mediastinal or hilar lymph nodes seen.
- Patent central airways.
- No pleural or pericardial effusions.
- Average size of the heart with normal CT of its big vessels.
- Normal bones of the thoracic cage.
- Average sized liver, measuring about 14.7cm, showing a normal parenchymal attenuation and a homogenous enhancement pattern.
- No sizable abnormally-enhancing focal lesions or dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen,measuring about 11cm. No focal lesions seen inside.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, both suprarenal glands, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No intra-vesical stones,solid masses,wall thickening or diverticulosis seen.
- A small left ovarian cyst is seen and measures about 38x33mm in dimensions.
- The rest of the pelvic structures are unremarkable.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient's Name:	**Sharifah Abdallah Ewais Hasanen**
Date:	**2026-08-09**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

IMPRESSIONS:

- **An enhancing neoplastic mass lesion in the left breast. The overlying skin is thickened,more in the peri-areolar region with left axillary metastatic lymph nodes.**
- **Hyperinflated both lungs with bilateral increased broncho-vascular markings.**
- **Otherwise,normal study.**

Prof/Hanan El-Ahwal.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient ID: 12355655	Patient Name English: Sherifa abedalla
:Age	2026/07/12 12:56:58 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 42 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- UOQ irregular spiculated dense mass with surrounding architectural distortion.
- No asymmetries or clusters of suspicious microcalcifications
- **Ultrasound revealed :**
  - 1 o'clock irregular heterogeneous hypoechoic mass lesion, measuring 4.32 x 2.79 cm, with anterior extension measuring about 2.44cm located about 4 cm from nipple, 0.64 cm from overlying skin, showing internal vascularity on color Doppler study.
  - Retroareolar prominent hyperechoic ducts.
  - Normal nipple/areolar complex.
  - Less than 3 enlarged pathological axillary LNs with thickened cortex and effaced hilum, largest measuring 3.09 x 1.52 cm with cortical thickening reaching up to 0.87cm
  - Free supra and infraclavicular regions.

Commented [p11]:

Right breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound revealed :**
- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesions as described with pathological level I axillary LNs. for Tru cut biopsy and CESM study**
- **Right breast (BIRADS 1): normal study.**

Much obliged,
Dr. Esraa Elsayed
Dr. Ghada Khaled

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

NHTMRI

قسم الباثولوجى

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: شريفه عبدالله عويس حسين | Age:42 years | Sex: female
Request type: مبادره | Sub request type:
Hospital no: | Pathology no.:644-2026
Department:صحه مرأه | Date of result:1/8/2026
Referred by: د/مروه حسن | Date of biopsy:15/4/2026
Nature of specimen: tru-cut biopsy | I.D. Number:28402162100722
Clinical diagnosis: Left breast mass

Gross pathology :
Muliplte grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:. Section examined revealed core of tumor showing invasive duct carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and cribriform pattern infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There is moderate number of mitotic figures. No carcinoma insitu component is seen.

Immunohistochemical Result;
ER: Strong nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Moderate nuclear staining of 30% of tumor cells (Allred Score 5/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining in >10% of tumor cells (score 1+). Her2 low
Ki67: Positive nuclear staining of 70% of tumor cells.

Diagnosis:Left breast mass,tru cut biopsy:
Invasive Duct Carcinoma, (NST) Grade III.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient ID: 12355655	Patient Name English: Sherifa abedalla
:Age	2026/07/12 12:56:58 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 42 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- UOQ irregular spiculated dense mass with surrounding architectural distortion.
- No asymmetries or clusters of suspicious microcalcifications
- **Ultrasound revealed :**
  - 1 o'clock irregular heterogeneous hypoechoic mass lesion, measuring 4.32 x 2.79 cm, with anterior extension measuring about 2.44cm located about 4 cm from nipple, 0.64 cm from overlying skin, showing internal vascularity on color Doppler study.
  - Retroareolar prominent hyperechoic ducts.
  - Normal nipple/areolar complex.
  - Less than 3 enlarged pathological axillary LNs with thickened cortex and effaced hilum, largest measuring 3.09 x 1.52 cm with cortical thickening reaching up to 0.87cm
  - Free supra and infraclavicular regions.

Commented [p11]:

Right breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound revealed :**
- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesions as described with pathological level I axillary LNs. for Tru cut biopsy and CESM study**
- **Right breast (BIRADS 1): normal study.**

Much obliged,
Dr. Esraa Elsayed
Dr. Ghada Khaled

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient ID: 12355655	Patient Name English: Shefa abedalla
:Age	2026/07/12 12:56:58 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 42 years old female patient with left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- UOQ irregular spiculated dense mass with surrounding architectural distortion.
- No asymmetries or clusters of suspicious microcalcifications
- **Ultrasound revealed :**
  - 1 o'clock irregular heterogeneous hypoechoic mass lesion, measuring 4.32 x 2.79 cm, with anterior extension measuring about 2.44cm located about 4 cm from nipple, 0.64 cm from overlying skin, showing internal vascularity on color Doppler study.
  - Retroareolar prominent hyperechoic ducts.
  - Normal nipple/areolar complex.
  - Less than 3 enlarged pathological axillary LNs with thickened cortex and effaced hilum, largest measuring 3.09 x 1.52 cm with cortical thickening reaching up to 0.87cm
  - Free supra and infraclavicular regions.

Commented [p11]:

Right breast:

- Heterogeneous fibro glandular densities (ACR density C).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound revealed :**
- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 5): Left UOQ malignant mass lesions as described with pathological level I axillary LNs. for Tru cut biopsy and CESM study**
- **Right breast (BIRADS 1): normal study.**

Much obliged,
Dr. Esraa Elsayed
Dr. Ghada Khaled

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهه الاصدار :فرع الجيزة

تاريخ الاصدار :14-7-2026

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) شريفه عبدالله عويس بطاقة رقم 28402162100722

تليفون رقم: لايوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

الهيئة العامة للتأمين الصحي
فرع الجيزة
إدارة النظم والمعلومات
قسم المعلومات

الموظف المختص
منى ابو الخير

تاريخ الطباعه :14-7-2026

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2022711

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى